

ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม

Effectiveness of brain potential development activities based on the health belief model among older adults at a community in Nakhon Pathom Province

ชลธิชา ชลสวัสดิ์ และสุลาลี ทองวิเชียร

Chonticha Chonsawat and Sulee Tongvichean

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองซึ่งประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ 2) แบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพ และ 3) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม หาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาได้เท่ากับ 0.89, 0.93 และ 0.86 ตามลำดับ หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพและแบบวัดความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ได้เท่ากับ 0.78 และ 0.72 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า หลังได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง ผู้สูงอายุทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมอยู่ในระดับสูง และมีความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและในด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม การรับรู้ความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน สูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แต่ด้านการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติต่ำกว่าก่อนได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง, แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ

ได้รับทุนวิจัย จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Corresponding author E-mail: st25401@hotmail.com

วันที่รับบทความ: 6 ตุลาคม 2568 วันที่แก้ไขบทความ: 10 ธันวาคม 2568 วันที่ตอบรับบทความ: 11 ธันวาคม 2568

(กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2564)

สมองเป็นอวัยวะที่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต การทำกิจกรรมบริหารสมองร่วมกับการดูแลสุขภาพกายและใจ เป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของสมอง (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2563) ขณะเดียวกัน ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยเสี่ยง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถวางแผนการดูแลตนเองได้เหมาะสมมากขึ้น (ธรรณิษฐ์ คุณแขวน และคณะ, 2566) สอดคล้องกับวิมลรัตน์ บุญเสถียร และคณะ (2565) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมักมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การส่งเสริมความรู้และการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว

งานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้ว ขณะที่งานวิจัยที่มุ่งเน้นการรับรู้และการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ยังมีจำนวนน้อย ผู้สูงอายุจำนวนมากมักเข้าใจว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นเรื่องธรรมชาติของวัย จึงไม่ได้เฝ้าระวังอาการเบื้องต้น และดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ส่งผลให้มาพบแพทย์เมื่ออาการรุนแรงหรืออยู่ในระยะสมองเสื่อมแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพสมอง ผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief model [HBM]) ของ Becker และ Maiman (1975) ซึ่งอธิบายว่าบุคคลจะเกิดพฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้เมื่อรับรู้ว่าคุณเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค (perceived susceptibility) ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค (perceived severity) รับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน (perceived benefits) และรับรู้ว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าอุปสรรค

ในการปฏิบัติ (perceived barriers) เมื่อบุคคลมีความเชื่อเหล่านี้ ย่อมมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่เหมาะสม

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ (สุทธิทองวิเชียร, 2566) โรคเรื้อรังเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง เมื่อหลอดเลือดตีบหรือถูกทำลาย จะทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว (ภรณ์วิทย์ อนันต์ดีลฤทธิ, 2564) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุจำนวนมากอาศัยอยู่ลำพังเนื่องจากบุตรหลานออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง (สุทธิทองวิเชียร, 2566) การขาดกิจกรรมกระตุ้นสมองและการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้การเสื่อมของสมองเกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้น (ภรณ์วิทย์ อนันต์ดีลฤทธิ, 2564) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย โดยใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อชะลอความเสื่อมของสมองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความเสี่ยง เห็นคุณค่าของการป้องกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์

เฉพาะ ดังนี้

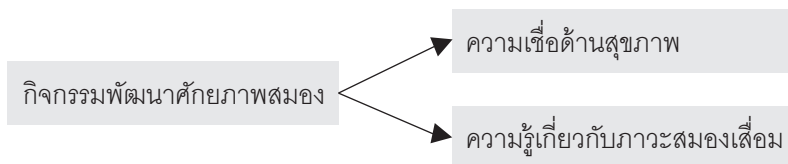
1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม ภายหลังได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง
2. เปรียบเทียบความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและในรายด้านของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม การรับรู้ความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม ระหว่างก่อนและหลังได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง

สมมติฐานการวิจัย

ผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม มีความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม และในรายด้านของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม การรับรู้ความรุนแรงของภาวะ

สมองเสื่อม การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน สูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง แต่มีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติต่ำกว่าก่อนได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง

กรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยได้ประยุกต์แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ ของ Becker และ Maiman (1975) ซึ่งอธิบายว่าบุคคลจะเกิดพฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้เมื่อมีความเชื่อว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค รับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าอุปสรรคในการปฏิบัติ เมื่อบุคคลมีความเชื่อเหล่านี้ ย่อมมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่เหมาะสม จึงได้นำแนวคิดนี้มาออกแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนสมอง และประเมินประสิทธิผล เขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้ดังนี้



วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร เป็นผู้สูงอายุในอำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจำนวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลศาลายา จำนวน 210 คน (เทศบาลตำบลศาลายา, 2567)

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-75 ปี ที่ได้รับการประเมินจากแบบประเมินสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (TMSE) มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 23 คะแนน จากคะแนนเต็ม

30 คะแนน และมีคะแนน Recall น้อยกว่า 3/3 (Train the Brain Forum Committee, 1993) เกณฑ์การคัดออกคือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้โปรแกรม G*Power 3.1 (Faul et al., 2007) ใช้สถิติ paired t-test กำหนดความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญ .05 ค่าอำนาจการทดสอบ (power) .80 และค่าอิทธิพล (effect size) ขนาดกลาง 0.50 (Cohen, 1992) ได้ขนาดตัวอย่าง 27 คน เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างการวิจัยจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 10 ได้จำนวน 30 คน

เครื่องมือวิจัย

1. **กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง** ผู้วิจัยสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองโดยใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพของ Becker และ Maiman (1975) เน้นการให้ความรู้ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อด้านสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ครอบคลุมประเด็น "รู้เท่าทันสมองเสื่อม" ปัจจัยเสี่ยง อาการแสดง ในระยะต่าง ๆ 2) การรับรู้ความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม ครอบคลุมประเด็น ผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจที่ตามมา 3) การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน ครอบคลุมการเฝ้าสังเกตอาการเบื้องต้น ประโยชน์ของการป้องกัน หลักโภชนาการ เกี่ยวกับอาหารชะลอการเสื่อมของสมอง และอาหารที่เหมาะสมกับโรคประจำตัว การบริหารสมองพื้นฐานสองซีก 4) การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ โดยติดตามผลการนำไปปฏิบัติและสอบถามอุปสรรคเป็นรายบุคคล ผ่านการเยี่ยมบ้าน หรือ โทรศัพท์ส่วนบุคคล เพื่อให้การช่วยเหลือในการลดอุปสรรคที่รับรู้

2. **แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล** ครอบคลุมเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัวและโรคประจำตัว

3. **แบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพ** ผู้วิจัยนำแนวคิดแบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพของ Becker และ Maiman (1975) มาสร้างเนื้อหา จำนวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จำนวน 8 ข้อ 2) การรับรู้ความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม จำนวน 7 ข้อ 3) การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน จำนวน 6 ข้อ และ 4) การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ จำนวน 4 ข้อ การตอบใช้มาตราประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 4-1 ตามลำดับ การแปลผลระดับใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 3.00-4.00 หมายถึง ระดับมาก 2.00-2.99 หมายถึง ระดับปานกลาง และ 1.00-1.99 หมายถึง ระดับน้อย

4. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม

จำนวน 11 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้นครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุของโรคสมองเสื่อม อาการและอาการแสดง อาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง และอาหารบำรุงสมอง การตอบ ให้เลือกตอบ ถูก หรือผิด กำหนดคะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน การแปลผลระดับใช้เกณฑ์ร้อยละของคะแนนรวมดังนี้ ระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับปานกลาง ร้อยละ 60-79 และระดับต่ำ น้อยกว่า ร้อยละ 59 (Bloom, 1964)

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย

หาความตรงเชิงเนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence [IOC]) เท่ากับ 0.89 แบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพ และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.93 และ 0.86 ตามลำดับ และหาความเที่ยงโดยนำไปทดสอบใช้กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 30 คน แบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ เท่ากับ 0.78 และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง KR 20 เท่ากับ 0.72

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2568

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารรับรองเลขที่ COA 11/2568 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ผู้วิจัยให้เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่างในรายละเอียดของโครงการวิจัย การให้สิทธิถอนตัวหรือยุติการเข้าร่วมโครงการวิจัย การรักษาความลับส่วนบุคคลโดยนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามในใบยินยอมเป็นรายบุคคล

คณะผู้วิจัย จำนวน 4 คน เป็นผู้วิจัย จำนวน 2 คน และมีผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 คน เป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งได้รับการชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. **ระยะก่อนการทดลอง** ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยตนเองที่บ้าน และรับกลับเมื่อตอบเสร็จ กรณีที่ผู้สูงอายุอ่านหนังสือมองไม่ชัด ผู้วิจัยได้เป็นผู้อ่านให้ฟัง และให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบใช้เวลาตอบประมาณ 20 นาที

2. **ระยะทดลอง** ผู้วิจัยดำเนินการตามโปรแกรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองผู้สูงอายุกลุ่มโดยพบผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลที่บ้านผู้สูงอายุ ใช้เวลา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ½ ชั่วโมงต่อคน รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 สุขศึกษา "รู้เท่าทันสมองเสื่อม" ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหน้าที่ของสมอง ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยสาเหตุ อาการแสดงในระยะต่าง ๆ ผลกระทบ และอาการแสดงเบื้องต้นในผู้สูงอายุ โดยเน้นการสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม

สัปดาห์ที่ 2 โภชนาการและการบริหารสมอง พื้นฐาน ให้ความรู้เรื่อง อาหารบำรุงสมอง ที่สอดคล้องกับโรคประจำตัว และแนะนำ หลักการบริหารสมองทั้งสองซีก รวมถึงทำบริหารเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจวัตรประจำวัน เน้นการรับรู้ประโยชน์

สัปดาห์ที่ 3 การฝึกปฏิบัติบริหารสมองเฉพาะ ฝึกปฏิบัติทำบริหารสมอง 4 ท่าหลัก ได้แก่ ท่าจีบแอล ท่าโป่ง-ก้อย ท่าเตะหู และท่าเตะหู-เตะจมูก ผู้วิจัยสาธิต และให้ผู้สูงอายุ สาธิตย้อนกลับ พร้อมร่วมกันวางแผนจัดสรรเวลา สำหรับการบริหารสมอง 4 ท่านี้ เน้นการลดอุปสรรคและเสริมความมั่นใจในตนเอง

สัปดาห์ที่ 4-6 การเสริมแรงและติดตามผลแบบบูรณาการ สร้างช่องทางไลน์กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำ คลิปวิดีโอ (video) ส่งในไลน์กลุ่ม (group LINE) เพื่อทบทวนความรู้ ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยเสี่ยง การบริหารสมอง ติดตามการนำไปปฏิบัติโดยการเยี่ยมบ้าน และ/หรือติดตามทางโทรศัพท์ ในกรณีไม่สะดวกเยี่ยมบ้านเพื่อกระตุ้นเตือนและสอบถามอุปสรรคในการปฏิบัติ

3. **ระยะหลังทดลอง** สัปดาห์ที่ 7 ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความเชื่อด้านสุขภาพ และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมให้ผู้สูงอายุตอบเป็นรายบุคคล และรับกลับเมื่อตอบเสร็จ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ตรวจสอบลักษณะข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นที่มีลักษณะการแจกแจงของชุดข้อมูลเป็นแบบปกติ (normal distribution)

ผลการวิจัย

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.7 มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี ร้อยละ 83.3 สถานภาพสมรสเป็น คู่ ร้อยละ 83.3 ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 93.3 โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 33.3 รองลงมา ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 26.7

2. **ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม** ภายหลังได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง พบว่า หลังได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง ผู้สูงอายุทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.433 (SD = 0.679) ในรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.700 -1.000 (ตาราง 1)

จริงและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเน้นประเด็นสำคัญว่าภาวะนี้จะส่งผลให้เป็นภาวะต่อครอบครัว เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การสื่อสารนี้ทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงความเสี่ยงทั้งด้านร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Becker และ Maiman (1975) ที่ระบุว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกิดขึ้นเมื่อโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การทำงาน หรือครอบครัว และสอดคล้องกับ เกษริน อุบลวงศ์ และนัยนา พิพัฒน์วิไลชา (2560) ที่พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคสมองเสื่อมกับพฤติกรรมการป้องกันโรค

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน การจัดกิจกรรมได้มุ่งเน้นการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับอาหารบำรุงสมองและการบริหารสมองสองซีกที่สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมประจำวัน การร่วมกันวางแผนจัดสรรเวลา และใช้ทำบริหารที่ง่ายซึ่งสามารถทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้ เป็นการสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่นว่าการปรับพฤติกรรมจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี สอดคล้องกับ Becker และ Maiman (1975) ที่ว่าเมื่อบุคคลรับรู้ว่าการป้องกันโรคเป็นการกระทำที่ดี ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเจ็บป่วย ก็จะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ เกษริน อุบลวงศ์ และนัยนา พิพัฒน์วิไลชา (2560) และ ศรุตยา หวางษ์ และคณะ (2560) ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคสมองเสื่อม

ด้านการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ การที่ผู้วิจัยกับผู้สูงอายุร่วมกันวางแผนจัดสรรเวลา และประยุกต์ทำบริหารสมองให้เข้ากับกิจกรรมประจำวัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ มีบทบาทสำคัญในการลด

อุปสรรคที่รับรู้ และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองว่าการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมนั้นสามารถทำได้จริง สอดคล้องกับ Becker และ Maiman (1975) ที่ว่าเมื่อบุคคลมีความพร้อมในการปฏิบัติสูงและรับรู้อุปสรรคต่ำ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากขึ้น

2. หลังได้รับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง ผู้สูงอายุทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้ ที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยการให้ความรู้แบบรายบุคคล การกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติบริหารสมองจริง นอกจากนี้การใช้ช่องทางไลน์กลุ่มในการเสริมข้อมูลผ่านวิดีโอเพิ่มเติม ยังเป็นการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และต่อเนื่อง ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมนี้จะเป็น ฐานรากสำคัญที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการป้องกันโรคสมองเสื่อม

ข้อเสนอแนะ

1. คณะอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และบุคลากรด้านสุขภาพ สามารถนำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองไปใช้ในการสอนนักศึกษาและดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และมีความเชื่อด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในระยะยาว

2. ควรมีการติดตามผลของการพัฒนาศักยภาพสมองในระยะยาวเพื่อดูความคงทนของศักยภาพสมอง และศึกษาเปรียบเทียบการใช้ช่องทางไลน์กลุ่มในการเสริมข้อมูลผ่านวิดีโอกับการใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน และการสอนในคลินิกตามปกติ อีกทั้งควรมีกิจกรรมควบคุมด้วยเพื่อยืนยันประสิทธิผลที่ชัดเจนขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต. (2564, 6 ตุลาคม). ภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์. <https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=31135>